

# Reconstrucción del uréter

WARWIKI

Información para el paciente · Cirugía para reparar un uréter bloqueado o estrecho

La reconstrucción del uréter es una cirugía para reparar un uréter bloqueado o estrecho — el tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga — y restaurar el flujo libre y proteger el riñón. Cómo se hace depende de dónde está el estrechamiento y de su longitud; la reparación puede usar los propios extremos del uréter, un injerto de tejido o un trozo de intestino.

## Acerca de este procedimiento

Una **estrechez** (un estrechamiento con cicatriz) en el uréter retiene la orina detrás y puede dañar el riñón. La reparación se adapta al estrechamiento:

- **Estrechez corta** — se quita el segmento dañado y se cosen los extremos sanos, o se reconecta el uréter a la vejiga (a veces se estira la vejiga hacia arriba para alcanzarlo).
- **Estrechez más larga** — el uréter se abre con un **injerto**, a menudo un trocito del interior de la mejilla (esto tiene su propia hoja).
- **Daño muy largo o grave** — se usa un segmento de su propio **intestino** para unir o reemplazar el uréter faltante.

Se coloca un **catéter** interno blando para mantener abierta la reparación mientras cicatriza. Suele hacerse **por robot o laparoscopia** (con incisiones pequeñas), a veces abierta. El éxito es alto.

## ¿Es segura?

Son reparaciones bien establecidas y eficaces, con la técnica ajustada a su anatomía. Como toda cirugía mayor tiene algún riesgo — sangrado, infección o un escape temporal de orina (suele controlarse con el catéter y un drenaje). Es raro que el estrechamiento regrese. Si se usa un trozo de intestino, el intestino necesita unos días para recuperarse y puede notar algo de moco en la orina.

## APRENDA LOS TÉRMINOS

### Uréter

El tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga.

### Estrechez

Una zona estrecha con cicatriz que frena o bloquea el flujo de orina.

### Catéter ureteral

Un tubo interno blando (un “doble J”) que mantiene abierta la reparación mientras cicatriza.

### Injerto

Un parche pequeño de su propio tejido, a menudo del interior de la mejilla, para ensanchar el uréter.

### Segmento de intestino

Un trozo corto de su propio intestino para unir un hueco largo.

### Reimplante

Reconectar el uréter a la vejiga.

### Hidronefrosis

Hinchazón del riñón porque la orina se acumula detrás del bloqueo.

### Robótica / laparoscopia

Cirugía por incisiones pequeñas.

**¿LE DOLERÁ?** La cirugía se hace con anestesia general, así que no siente nada durante ella. Después, espere molestias en las incisiones, y el catéter interno puede causar algo de urgencia o una molestia leve en el costado. Si se usa un trozo de intestino, este tarda unos días en “despertar”. La mayoría se queda 1–3 noches; la duración depende de la reparación.

## Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general** — siga todas las instrucciones (ayuno y qué medicinas suspender, incluso anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** busca infección — debe tratarse primero.
- **No fume** — retrasa la cicatrización. Si puede usarse intestino, quizá necesite preparación intestinal; si puede usarse injerto de mejilla, cuide su boca.
- Prevea un **catéter unas 4–6 semanas** y consiga quién lo lleve a casa.

### Avisé a su equipo con antelación si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección actual
- Tuvo cirugía abdominal o pélvica previa, o radiación

## Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido con anestesia y se dan antibióticos.
- 2 El cirujano hace incisiones pequeñas o abiertas y expone el segmento estrecho.
- 3 Se repara el uréter — uniendo los extremos, con un injerto o con un trozo de intestino — sobre un catéter.
- 4 Puede dejarse un drenaje pequeño y se cierran las incisiones.

## Después de la cirugía

- Suele ir a casa en **1–3 días**.
- El **catéter queda dentro unas 4–6 semanas** y luego se retira con una cistoscopia rápida en consulta.
- Los síntomas del catéter — urgencia, molestia leve en el costado u orina rosada — son **normales**.
- Si se usó intestino, coma liviano mientras se recupera. **Evite levantar peso** unas semanas.

### Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dolor intenso o creciente en el costado o el vientre
- Sangrado abundante, o no puede orinar
- Vómitos persistentes, o sin gases ni evacuación (si se usó intestino)
- Más enrojecimiento, dolor o secreción en una incisión

## TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La reconstrucción del uréter reabre un uréter bloqueado para proteger el riñón. La reparación se adapta a usted — unir los extremos, un injerto de mejilla o un trozo de intestino — sobre un catéter interno.
2. Para prepararse: siga las instrucciones de ayuno y medicinas, trate primero toda infección, no fume, prevea un catéter unas 4–6 semanas y consiga transporte.
3. Espere que el catéter cause algo de urgencia hasta que se retire en la consulta. Llame de inmediato si hay fiebre, dolor intenso, sangrado abundante, no poder orinar o falta de actividad intestinal tras la cirugía.